

SIBO : *comprendre* les bases.

Les signes qui ne trompent pas, les 5 erreurs qui retardent la guérison, et un quiz pour savoir si votre profil correspond.

Par **Sabrina Castelli** — Naturopathe, ancienne patiente SIBO
Extrait du guide complet « SIBO : comprendre, tester, agir. »

CHAPITRE 01

Ce qu'est vraiment *le SIBO*.

Comprendre le SIBO en 10 minutes — sans formation médicale, sans jargon inutile.

CE QUE C'EST

Ce n'est pas « le stress », ni une sensibilité alimentaire, ni une colopathie fonctionnelle. C'est une prolifération bactérienne dans un endroit précis — identifiable, testable, traitable.

SIBO signifie Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Votre intestin grêle, long de 6 mètres, est normalement très peu peuplé en bactéries. Dans le SIBO, des bactéries du côlon remontent et colonisent cet espace. Elles fermentent les glucides que vous mangez avant que votre intestin ait eu le temps de les absorber — produisant des gaz (hydrogène H₂, méthane CH₄, ou sulfure d'hydrogène H₂S) responsables de vos symptômes.

Ce n'est pas qu'un problème de confort. Non traité, le SIBO provoque une malabsorption réelle des vitamines B12, D, du fer et du magnésium — d'où la fatigue chronique et les carences récurrentes malgré une alimentation soignée.

LES 7 SIGNES QUI NE TROMPENT PAS

- Ballonnements marqués après les repas, surtout riches en glucides — empirent en fin de journée
- Transit perturbé : diarrhée chronique, constipation sévère, ou alternance imprévisible
- Fatigue profonde, non proportionnelle à vos nuits
- Carences répétées (B12, fer, vitamine D) malgré une alimentation équilibrée
- Reflux gastro-œsophagien associé à des troubles digestifs bas
- Brouillard mental — concentration difficile, mémoire floue après les repas
- Les probiotiques aggravent vos symptômes — c'est le signe le plus caractéristique du SIBO actif

LE SIGNAL QUE TOUT LE MONDE RATE

Si vous prenez des probiotiques et que vos ballonnements, votre fatigue ou vos réactions histaminiques s'aggravent — c'est probablement du SIBO. C'est un signal important à mentionner dès le début de votre consultation : selon votre type de SIBO, la conduite à tenir sur les probiotiques n'est pas la même pour tout le monde.

SIBO VS INTESTIN IRRITABLE

Les études récentes montrent que 38 à 78% des personnes diagnostiquées « intestin irritable » ont en réalité un SIBO – dont la plupart n'ont jamais été testées. L'intestin irritable est un diagnostic d'exclusion. Le SIBO est une cause identifiable.

38–78%

des SII sont en réalité un SIBO

1/3

développe un SIBO après une gastro-entérite sévère

Source : Pimentel M. et al. (2020) – ACG Clinical Guideline: SIBO. Am J Gastroenterol. / Ford AC et al. (2020) – Functional Bowel Disorders. Gastroenterology.

POURQUOI ÇA ARRIVE

L'intestin grêle dispose de trois barrières naturelles contre la pullulation bactérienne : l'acidité gastrique, les mouvements du Complexe Moteur Migrant (CMM – le « nettoyage » entre les repas), et la valvule iléo-cæcale. Quand l'une de ces barrières se dérègle – IPP au long cours, stress chronique, gastro-entérite sévère, hypothyroïdie – le SIBO peut s'installer.

POURQUOI CE GUIDE S'ARRÊTE ICI

Comprendre le mécanisme est la première étape. Identifier VOTRE déclencheur précis, votre type de SIBO et le protocole adapté à votre terrain – c'est le travail qu'on fait ensemble en consultation, pas quelque chose qu'on peut standardiser dans un guide.

CHAPITRE 02

Les 5 erreurs *qui retardent tout*.

Ce que la plupart des femmes font — souvent sur conseil médical — et qui empire la situation. Ces erreurs ne sont pas des fautes de votre part.

ERREUR 01 — COMMENCER PAR LES PROBIOTIQUES

C'est la première chose que prescrivent la plupart des médecins et naturopathes face à des troubles digestifs. En cas de SIBO actif, c'est souvent la pire chose à faire. Les bactéries lactiques nourrissent directement la pullulation et aggravent les symptômes.

→ Les probiotiques viennent après l'éradication, jamais avant — et le choix de la souche se décide avec votre praticien selon votre type de SIBO. Ce n'est pas un détail : la mauvaise souche au mauvais moment peut relancer la pullulation.

ERREUR 02 — SUIVRE UN RÉGIME LOW-FODMAPS À VIE

Le régime Low-FODMAPs soulage les symptômes en réduisant la fermentation — mais il ne traite pas la cause. Certaines femmes le suivent pendant des années, voient leurs symptômes revenir dès qu'elles écartent des aliments, et pensent que c'est « leur sensibilité personnelle ». C'est en réalité le signe que la pullulation est toujours là.

→ Low-FODMAPs = outil temporaire pendant le traitement, pas solution permanente.

ERREUR 03 — GRIGNOTER TOUTE LA JOURNÉE

Entre les repas, votre intestin grêle se nettoie grâce à des contractions péristaltiques puissantes (le Complexe Moteur Migrant). Ce mécanisme ne fonctionne qu'à jeun. Chaque grignotage l'interrompt. Les femmes qui mangent en continu – même sainement – entretiennent la pullulation sans le savoir.

→ Laisser 4 à 5 heures entre les repas sans rien ingérer (sauf eau). C'est souvent plus efficace que n'importe quelle restriction alimentaire.

ERREUR 04 — TRAITER SANS TYPÉ LE SIBO

Il existe 3 types de SIBO (hydrogène, méthane, sulfure d'hydrogène) avec des protocoles différents. Sans test, on traite à l'aveugle – et certaines approches efficaces sur un type peuvent aggraver un autre type.

→ Un test respiratoire lactulose ou glucose est indispensable avant tout protocole.

ERREUR 05 — TRAITER LE SIBO SANS CHERCHER LA CAUSE RACINE

40% des personnes rechutent dans les 9 mois après traitement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont traité la pullulation sans identifier ce qui l'a déclenchée : hypothyroïdie non traitée, IPP au long cours, stress chronique, séquelle d'une gastro-entérite ancienne... Sans identifier le « premier domino », la récurrence est presque certaine.

→ Remonter la cascade causale est aussi important que le traitement lui-même.

CHAPITRE 03

Est-ce que c'est *mon profil* ?

Un quiz clinique pour identifier si vos symptômes correspondent à un profil SIBO — et lequel. Basé sur les critères de Rome IV et les guidelines ACG 2020.

SECTION A — SYMPTÔMES DIGESTIFS

Je me bats avec des ballonnements presque quotidiens, surtout après les repas — et ils empirent en fin de journée.	OUI / NON
Mon transit est imprévisible : constipation sévère, diarrhée, ou les deux en alternance.	OUI / NON
J'ai des douleurs ou crampes abdominales basses qui ne disparaissent pas malgré les antispasmodiques.	OUI / NON
J'ai des reflux gastro-œsophagiens en plus de mes troubles digestifs bas.	OUI / NON
Quand je prends des probiotiques, mes symptômes s'aggravent plutôt qu'ils ne s'améliorent.	OUI / NON

SECTION B — SIGNES SYSTÉMIQUES

J'ai une fatigue chronique difficile à expliquer.	OUI / NON
J'ai des carences répétées (B12, fer, vitamine D) malgré une alimentation équilibrée.	OUI / NON
J'ai un brouillard mental, une mémoire qui flanche.	OUI / NON
Je réagis à de nombreux aliments — lactose, fructose, FODMAPs, histamine.	OUI / NON

SECTION C — CONTEXTE ET DÉCLENCHEURS

Mes symptômes ont commencé ou se sont aggravés après une gastro-entérite sévère, une prise d'antibiotiques, ou une chirurgie abdominale. OUI / NON

Je prends ou j'ai pris des IPP pendant plus de 3 mois. OUI / NON

J'ai une hypothyroïdie, un SOPK, de l'endométriose, ou un déséquilibre hormonal diagnostiqué ou suspecté. OUI / NON

On m'a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable sans jamais me proposer de test respiratoire. OUI / NON

CALCULEZ VOTRE SCORE — COMPTEZ VOS OUI

SCORE	ORIENTATION	PROCHAINE ÉTAPE
1–3	Profil peu probable	Explorer d'autres pistes (dysbiose colique, intolérances simples)
4–6	Profil à investiguer	Demander un test respiratoire lactulose à votre médecin ou via un laboratoire en ligne
7–13	Profil très concordant	Test respiratoire en priorité + bilan complet (thyroïde, fer, B12, hormones)

Ce quiz oriente — il ne diagnostique pas. Seul un test respiratoire peut confirmer un SIBO et en identifier le type. Le guide complet vous explique comment l'obtenir, comment vous y préparer, et comment lire vos résultats vous-même.

Maintenant, *comprendre pour agir.*

Vous avez le tableau clinique. La prochaine étape : comprendre votre type de SIBO, obtenir le bon test, et savoir comment on avance ensemble.

- Physiologie détaillée avec 5 schémas sur mesure
- Les 3 types de SIBO – H₂, CH₄, H₂S – et leurs profils cliniques
- Test respiratoire : comment le demander, le préparer, lire vos résultats
- Le protocole en 4 phases, dans le bon ordre
- Les grandes familles de solutions naturelles selon votre profil
- Alimentation stratégique – listes pratiques semaine 1-2
- SIBO & hormones : l'estrobolome, SOPK, endométriose, ménopause
- Fiche imprimable : ma timeline SIBO
- Glossaire 16 termes + 13 sources scientifiques

IMPORTANT

Ce guide vous donne toutes les clés pour comprendre et vous tester. Le protocole précis – quelles plantes, quels dosages, dans quel ordre pour VOTRE profil – se construit uniquement en consultation. C'est volontaire : un protocole mal ajusté peut aggraver les choses.

22€ · avitaserena.com/ebook-sibo →